# SDD 309 Sujet n°1

## Spécialité : Psychiatrie

Date : 05/12/2023
Auteur : ELAYLI Robin (DES Psychiatrie Grenoble - ECN 2023)
Relecteur(s) : VILLARD Sébastien (DES Médecine Interne Paris - ECN 2023), Relu par PH de psychiatrie de Grenoble

| | |
|---|---|
| Domaine d'apprentissage principal | Interrogatoire/Entretien |
| Domaine d'apprentissage secondaire | Stratégie de prise en charge |
| Item(s) en lien avec la station | ITEM 353 Idées suicidaires |
| Situation(s) de départ en lien avec la station | SDD 309 Patient à risque suicidaire |
| Matériel nécessaire à la station | - Un bureau<br>- 2 Chaises<br>- Une feuille de brouillon<br>- Un stylo |
| Contexte de la station | Venue d'un patient aux urgences psychiatriques pour idées suicidaires |

| ECOS TACFA |
| --- |
| INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E |

**Contexte :**
Vous êtes un.e psychiatre de garde aux urgences psychiatriques.
Vous recevez M. Bellkre, 19ans, amené aux urgences par ses parents pour des idées suicidaires.
L'infirmière vous communique que ses constantes sont normales. Vous le voyez seul.e en entretien

**Consignes :**
Vous devez en 7 minutes :

- Réaliser l'interrogatoire
- Orienter le patient.

Vous ne devez pas :

- Faire un examen clinique
- Introduire un traitement médicamenteux
- Rechercher la cause de ces idées suicidaires.

Attention : Vous avez 7 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

| ECOS TACFA |
|---|
| GRILLE D'EVALUATION |

**Consigne(s) à l'évaluateur :**

| Aptitudes cliniques (max 15 items) | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | - Demande la raison de la venue aux urgences (laisse le patient évoquer de lui-même cette cause) | 1 pt | ☐ |
| 2. | - Demande si il y a des antécédents non psychiatriques personnels ET familiaux | 1 pt | ☐ |
| 3. | - Demande si il y a des antécédents psychiatriques personnels ET familiaux | 1 pt | ☐ |
| 4. | - Demande au patient s'il prend des traitements | 1 pt | ☐ |
| 5. | - Demande au patient s'il a un suivi psychiatrique OU psychologique | 1 pt | ☐ |
| 6. | - Interroge sur la présence d'idées suicidaires | 1 pt | ☐ |
| 7. | - Interroge sur le contenu des idées suicidaires | 1 pt | ☐ |
| 8. | - Interroge sur la date de début de ces idées suicidaires | 1 pt | ☐ |
| 9. | - Interroge sur la fréquence de ces idées suicidaires | 1 pt | ☐ |
| 10. | - Interroge sur l'intentionnalité suicidaire (geste fait avec intention de mourir) | 1 pt | ☐ |
| 11. | - Interroge sur la présence d'un scénario pour se suicider | 1 pt | ☐ |
| 12. | - Interroge sur si une date OU un délai pour passer à l'acte est décidé par le patient | 1 pt | ☐ |
| 13. | - Interroge sur au moins 2 des 4 éléments suivants :<br>● La présence de comportement de mise en danger<br>● La présence de comportement pour préparer leur passage à l'acte<br>● La présence d'élément protecteur<br>● Si des alternatives sont envisagées au suicide | 1 pt | ☐ |
| 14. | - Interroge sur de précédente tentative de suicide ET de comportement de mutilation auto-infligé | 1 pt | ☐ |
| 15. | - Hospitalisation en psychiatrie | 2 pt | ☐ |

| Communications et attitudes (ICI) (max 5 grilles) | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | **1. APTITUDE À ÉCOUTER : le patient / le pair** | 1 pt | ☐ |

| Performance Insuffisante<br><br>0 point | Performance Limite<br><br>0,25 point | Performance Satisfaisante<br><br>0,5 point | Performance Très Satisfaisante<br><br>0,75 point | Performance Remarquable<br><br>1 point |
|---|---|---|---|---|
| Interrompt le patient /pair de façon inappropriée<br><br>Ignore les réponses du patient/collègue | Se montre impatient | Est attentif aux réponses du patient/pair | Est attentif aux réponses du patient/pair<br><br>Adopte la technique de reformulation si l'information est imprécise ou éloignée des objectifs. | Porte une attention soutenue aux réponses du patient/pair et à ses préoccupations. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | **2. APTITUDE À QUESTIONNER** | 1 pt | ☐ |

| Performance Insuffisante<br><br>0 point | Performance Limite<br><br>0,25 point | Performance Satisfaisante<br><br>0,5 point | Performance Très Satisfaisante<br><br>0,75 point | Performance Remarquable<br><br>1 point |
|---|---|---|---|---|
| Pose des questions fermées ou trop directives ou qui ne répondent pas aux objectifs<br><br>Utilise le jargon médical | Pose des questions qui s'éloignent des objectifs<br><br>Utilise quelques fois un jargon médical sans explication | Utilise différents types de questions couvrant les éléments essentiels<br><br>Utilise quelques fois un jargon médical mais toujours avec explications | Pose des questions précises couvrant la plupart des éléments avec quelques omissions mineures<br><br>Utilise le langage approprié | Pose les questions avec assurance et savoir-faire |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | **4. APTITUDE À STRUCTURER/ MENER L'ENTREVUE** | 1 pt | ☐ |

| Performance Insuffisante<br><br>0 point | Performance Limite<br><br>0,25 point | Performance Satisfaisante<br><br>0,5 point | Performance Très Satisfaisante<br><br>0,75 point | Performance Remarquable<br><br>1 point |
|---|---|---|---|---|
| Approche désordonnée | Entrevue peu structurée, présente les difficultés à recadrer les discussions qui s'éloignent des objectifs | Entrevue centrée sur le problème et couvre les éléments essentiels | Entrevue menée de façon logique, structurée, centrée sur le problème, ne cherche pas l'information non pertinente | Entrevue ayant un but précis, approche intégrée |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. | **5. COMMUNICATION NON VERBALE** | 1 pt | ☐ |

| Performance Insuffisante<br><br>0 point | Performance Limite<br><br>0,25 point | Performance Satisfaisante<br><br>0,5 point | Performance Très Satisfaisante<br><br>0,75 point | Performance Remarquable<br><br>1 point |
|---|---|---|---|---|
| Se comporte de manière inappropriée (p. ex. ne regarde pas son interlocuteur, se comporte de manière offensante ou agressante) ou porte des jugements | Tente d'établir un contact visuel.<br><br>Présente les difficultés à établir la conversation (p.ex. priorise l'accomplissement de la tâche clinique) et cela peut induire la frustration du patient/pair | Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps<br><br>Établit la conversation | Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps<br><br>Est attentif aux indices du patient/pair et réagit de manière appropriée par son comportement/gestes. | Montre une bonne maîtrise de ses comportements et cherche à les adapter afin de favoriser la conversation /établir une relation. |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **…/ 20 points** |

**Éléments de rétroaction :**

La crise suicidaire est THE urgence psychiatrique. On définit par “crise suicidaire” la période où la personne risque de passer a l’acte (avec où sans intention de mourir).
Pour cela, ne tournez pas autour du pot, on pose la question direct : “Avez-vous des idées suicidaires ?”. Comme le dit le collège de psychiatrie, ce n’est pas cette question qui va générer un risque suicidaire.

Concernant l’interrogatoire des idées suicidaires, il faut qu’on trouve (en souligné = LES POINTS LES PLUS IMPORTANTS EN URGENCE) :

- **La fréquence**, si elles sont continue ou par intermittence
- **La durée** depuis leur apparition
- Si il y a une intention de mourir : on peut avoir des idées suicidaires sans souhaiter mourir. (voir plus bas).
- S’il y a un scénario pour mourir ou se faire du mal: par scarification, IMV, mise en danger… Cela montre que les idées suicidaires sont avancées.
- S’il y a une date/ un délai de prévision de passage à l’acte : C’est ce qui va vous indiquer le plus l’urgence de la situation.
- Si il a mis en place des comportements de départ : la question à poser est “avez mis en place des éléments en prévision de votre décès ? Pour faire vos adieux ?” Car le patient ne comprendra pas le terme comportement de départ. Il indique aussi à quel point le patient envisage son passage à l’acte.
- Si il a des comportements ordaliques : en posant la question “vous mettez vous en danger sans que les potentielles conséquences ne vous inquiètent ?” Les patients ne comprendront pas le terme comportement ordalique
- Les idées “velcros” : qui sont les causes qui pousseraient un patient à ne pas passer à l’acte

On estime que les idées suicidaires ont la chronologie suivante :
- Apparaissent en 1er le plus souvent comme des pensées de mort “passive”, sans qu'elles ne soient considérées comme une réelle solution (je ferais peut-être mieux de mourir…), ni qu’elles ne soient élaborées.
- Au fur-et-à mesure du temps, les autres solutions face au mal-être sont moindres, jusqu’à ce que l’unique solution envisagée soit le suicide.
- Les idées suicidaires s’affinent alors, avec la prévision d’un scénario pour les exécuter (je pense mourir par IMV, en me jetant d’un pont…)
- Enfin, le stade le plus préoccupant sera quand une date de mise en œuvre sera décidée par le patient. Il se peut alors qu’il commence à prendre des dispositions post-mortem.

Les mutilations auto-infligées ne sont pas forcément en lien avec un suicide, mais sont l’expression d’un terrain vulnérable, car le patient ne trouve comme solution pour calmer son mal-être que de se faire du mal. Cela témoigne souvent d’un état qui accompagne les idées suicidaires (mais il ne faut pas faire une généralité : auto-mutilation n’est pas égale à idées suicidaires forcément). Elles sont quand même à rechercher.

Les comportements ordaliques quant à eux peuvent être présents tout au long du processus chronologique des idées suicidaires. Ils informent sur la mise en danger

volontaire du patient. Leur utilité comme indication d'hospitalisation n'est cependant pas consensuelle actuellement.

Une hospitalisation est indiquée dès que les idées suicidaires sont élaborées avec un scénario et/ou un délai prévu. Le but est de garder le patient le temps que la crise suicidaire passe, et d'explorer en hospitalisation la raison de ces idées. Si non hospitalisation, on cherche à mettre en place un suivi psychiatrique ou psychologique pour explorer les causes de ces idées suicidaires, assurer une surveillance de leur évolution, et chercher une solution pour pallier la cause.
Certains services d'urgences psychiatriques auront tendance à garder le patient aussi selon d'autres éléments qui peuvent jouer :

- La place disponible dans le service.
- L'entourage du/de la patient.e.
- Dans le cas d'un.e enfant : l'épuisement parental.
- L'histoire du patient (antécédent de passage à l'acte notamment)

Si jamais on était dans une consultation post-passage à l'acte, on demanderait en plus si le/la patient.e critique son acte, ce qui indiquerait sa propension à repasser à l'acte et sa vision de l'acte suicidaire (le banalise ou comprends bien les conséquences)

Le polycopié parle des traits de personnalité comme un élément à rechercher. En pratique, à ma connaissance, cela correspond surtout à la recherche de l'impulsivité.

| ECOS TACFA |
| --- |
| SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ |

**Consignes génériques pour le patient :**

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

**Rappel du scénario du candidat** :

| |
| --- |
| Patient de 19 ans venant aux urgences pour idées suicidaires |

**Plan de la station ECOS** :

| |
| --- |
| Patient simulé en face de l'étudiant.e, de part et d'autre d'un bureau |

**<u>Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :</u>**

| |
| --- |
| "Bonjour docteur…" |

**Identité du patient :**

| |
| --- |
| Etienne Bellkre<br>19ans<br>1m78, 74kg |

**Mode de vie :**

| |
| --- |
| - Étudiant en sciences politiques<br>- Pratique le tennis<br>- Tabagisme 3 paquets années<br>- Alcool : peu de consommation hormis en soirée<br>- Rare consommation de cannabis |

**Comportement global** :

| |
| --- |
| - Triste, apathique |

**Antécédents personnels :**

Aucun

**Antécédents familiaux :**

Aucun

**Médicaments :**

Pas de traitement

**Symptômes positifs :**

- Si demande la raison de votre venue : “Mes parents m’ont amené ici parce que j’ai communiqué des idées suicidaires à des amis qui ont contacté mes parents”
- Si demande si les parents l’ont amené aux urgences : “ Oui ils ont appelé SOS suicide qui les a orienté ici”
- Si demande si vous avez des antécédents psychiatriques ou non-psychiatriques, personnels ou familiaux : “Non aucun”
- Si demande si vous prenez des traitements : “je ne prends pas de médicament, j’évite le plus possible”
- Si demande si vous avez un suivi psychiatrique/psychologique “Non aucun”
- Si demande si vous avez des idées suicidaires : “actuellement oui, beaucoup”
- Si demande depuis combien de temps : “ Pfff je sais pas… 3…4 semaines”
- Si vous demande la fréquence de ces idées suicidaires : “tout le temps,je ne pense qu’à cela”
- Si demande le contenu de ces idées suicidaires : “ Je ne sers à rien et je n’ai pas trop de solution donc autant en finir”
- Si demande si il y a une intentionnalité de mourir : “Oui je veux mourir”
- Si demande si il a un scénario : “Par médicament”
- Si demande quels médicaments : “je sais pas… un peu de tout…paracétamol, un truc sretaline la …”
- Si demande si il y a une date choisie “Bah dès que je rentre là j’ai les médicaments chez moi…”
- Si demande s’il a eu des comportements de mise en danger : “Bah ma vie vaut pas le coup donc autant mourir avec le hasard sinon”
- Si demande s’il y a eu des comportements ordaliques : “pfff je sais pas… c’est quoi”
- Si demande si avait mis en place un moyen pour faire vos adieux ? : “oui j’ai écris une lettre pour expliquer à mes parents et mes amis”.
- Si vous demande si vous avez eu des comportements de départs : “de départ, pour partir loin ? Je comprends pas”
- Si demande si vous vous êtes fait du mal : “Oui mais je le mérite donc bon”
- Si vous demande qu’est ce que vous faites pour vous faire du mal : “je me scarifie sur les bras”

- Si vous demande si vous vous mutilez/Scarifiez : “oui”
- Si vous demande la fréquence des scarifications : “tous les soirs”
- Si vous demande depuis quand vous vous Scarifier : “depuis longtemps, plusieurs mois, je sais plus combien”

**Constantes :**

Normale

**Questions de relance :**

- Si ne vous a pas pris en charge (doit vous hospitaliser) à 6 minutes : “je peux rentrer docteur ? “

| ECOS TACFA |
| --- |
| FEUILLET ORGANISATEUR (FACULTATIF) |

**Plan de la station ECOS :**

- Patient simulé et étudiant.e assis sur des chaises de part et d'autre d'un bureau

**Matériel nécessaire à la station :**

- *2 Chaises*
- *Un bureau*
- *Feuille de brouillon pour candidat*
- *Stylo pour candidat*
- *Feuille de brouillon pour évaluateur*
- *Stylo pour évaluateur*

**Documents présents dans la station :**

- *Feuilles d'évaluation de papier de secours*